



FICHA DE INGRESO PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Conforme a normativa chilena – Uso Clínico

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

- Nombre: Ana Carolina Soliz Carreño
- RUN: 21.530.801-4
- Fecha de nacimiento:
- Edad: 22 años
- Sexo: femenino
- Escolaridad: 2° años carrera trabajo social
- Establecimiento educacional: UCM
- Nombre del cuidador/tutor legal: mayor de 18 años
- Contacto:

2. MOTIVO DE CONSULTA

- Descripción del motivo de consulta: sospecha de diagnóstico de autismo
- Tiempo de evolución: Ana refiere haber sido diagnosticada en etapa de adolescencia (2018, 15 años) con “TEA” por neurologo, pero nunca se le explicó el diagnóstico ni a ella ni a su madre, ni se le entregaron los apoyos pertinentes. Actualmente vive en pensión en Talca, viaja a Constitución los fines de semana en donde vive con madre, abuela y hermanos. Refiere actualmente uso de clonazepam en sos indicado por médico general por “síntomas ansioso”. Menciona haber utilizado fluoxetina en el pasado, la cual suspendió por decisión propia por miedo a dependencia.
- Presenta realización de ADOS-2 reciente de año 2025 y ADI-R enviado informado como “con harta probabilidad de diagnóstico de autismo”(alto puntaje en dificultades en comunicación y a nivel social).
- Describe dificultades sociales desde la infancia, en donde describe ser muy callada, distraída y con tendencia a “estar en su propio mundo”. Refiere que durante su adolescencia debía planificar y practicar las conversaciones en su cabeza antes de interactuar con [otros.En](#) infancia preescolar recuerda no hablar con nadie, no tener amigos. Cuando le entregaron diagnóstico de autismo logra comprender sobre ella mas, intenta socializar mas
- Describe alta sensibilidad sensorial, especialmente ante ruidos fuertes como parlantes, camiones o gritos, los cuales le provocan mareos y una sensación de desconexión o bloqueo mental.

- Señala molestias con estímulos visuales excesivos, como presentaciones en ppt con muchos dibujos, y sensibilidad táctil ante etiquetas de ropa o texturas de ropa tipo “plásticas”.
- Con respecto animo: manifiesta ánimo bajo, caracterizado por agotamiento permanente, falta de ganas de realizar actividades y sentimientos de desesperanza sobre su futuro., miedo a no lograr sus metas.Describe crisis de pánico recurrentes que comienzan con mareos intensos, seguidos de falta de aire y sudoración fría.Reconoce haber tenido ideas de hacerse daño e ideación suicida durante la adolescencia, aunque actualmente refiere que estos.
- Realizó psicoeducación sobre su diagnóstico de TEA y de la necesidad de adquirir apoyos y herramientas, se validan sus logros, su resiliencia, se explica rol de fármacos en síntomas ansiosos y del ánimo. Se refuerza el vínculo. Se observa esperanzada.
- A nivel familiar buena relación con madre, la apoya, padre la amenaza con “cortar apoyos económicos”, esto la angustia mas.

3. ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS PERSONALES

- Diagnósticos previos: TEA entregado por neurologo
- Hospitalizaciones previas: no
- Tratamientos farmacológicos: clotiazepam en SOS, fluoxetina suspende por su cuenta hace algunos meses
- Psicoterapia previa:no
- Conductas autolesivas / ideación suicida:sin conducta autolesiva/ actualmente frente a ansiedad intensa conecta con ideas de no seguir viviendo, pero niega planificación estructurada, niega reales deseos de morir, sino mas bien de estar mejor.

4. ANTECEDENTES MÉDICOS GENERALES

- Patologías médicas relevantes: sana
- Tratamientos actuales: solo clotiazepam en SOS
- Alergias:niega

5. ANTECEDENTES FAMILIARES

- Antecedentes psiquiátricos familiares:
- Contexto psicosocial relevante:

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL

- Apariencia: constitución mesomorfa, se observa menor edad cronológica, vestimenta e higiene adecuada
- Actitud:cooperadora, a ratos lábil emocionalmente
- Psicomotricidad: se observa normal
- Lenguaje: Notificativo, atingente, sin alteraciones en estructura.
- Pensamiento: Sin alteraciones formales, niega delirios y niega alteraciones sensorio perceptuales hoy. Contenido en relación a dificultades en AVD y sociales
- Ánimo impresiona deprimida, ansiosa, lábil
- Contacto visual no evaluable ya que gran parte de entrevista solicita apagar cámaras
- Juicio de realidad: conservado, no psicótico.
- Insight: parcial

7. EVALUACIÓN DE RIESGO

- Riesgo suicida: si bien conecta con ideas de no querer vivir mas en periodos de mayor ansiedad asociado a pensamientos catastróficos, niega alguna vez ni actualmente planificación suicida concreta o estructurada, manifiesta deseos de alivio de su malestar psíquico, mas que deseos reales de querer morir. Finalmente manifiesta no desear hacerse daño, sino mas bien recibir ayuda.
- Factores de riesgo:neuro divergencia con dif sociales y sensoriales SIN APOYOS ni herramientas adquiridas, difícil acceso a apoyo de salud mental por dificultades económicas, escasa red de apoyo y ayudas sociales
- Factores protectores: motivación por recibir apoyos y herramientas, características personales de resiliencia en infancia y adolescencia. Presencia de madre como red de apoyo, buen nivel cognitivo, apertura a terapia, capacidad de pedir ayuda, cursando estudios universitarios, metas presentes.

8. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DSM-5 / CIE-11)

- Diagnóstico principal: Trastorno del espectro autista, obs trastorno por déficit atencional t. Ansioso, t.depresivo.
- Diagnósticos secundarios: violencia económica de parte del padre?

9. PLAN TERAPÉUTICO

- Tratamiento farmacológico: escitalopram 10 mg ½ por 5 días, luego 1 al día, clotiazepam 5 mg 1 cada 12 horas por 2 semanas, luego 1 al dia + 1 en sos y control. Se envia receta a madre vial mail debido a inestabilidad emocional actual, se indica estar presente en próximo control para activar red de apoyo.
- Intervenciones psicosociales:
- Derivaciones: a psicoterapia, a terapia ocupacional. Se realiza además solicitud de adecuaciones curriculares en periodos de mayores niveles de ansiedad.

10. SEGUIMIENTO

- Fecha próximo control: 3 semanas con madre para activar red de apoyo
- Red de apoyo: madre
- Indicaciones a cuidadores: presencia en próximo control

11. DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre: Caterina Schiappacasse Arteaga

Especialidad:psiquiatra infanto juvenil

Registro profesional:105595

Centro de atención: Psicoeduka Santiago

Fecha: 7 de julio 2026